

○ 長年気管支喘息として加療されていた症例が慢性血栓塞栓性肺高血圧症であったとする報告はあるが、一般的に喘息と肺高血圧症の関連はない。

✕ 診断時に 8~15%、進行すると 30~50% が肺高血圧症を呈する。

✕ 睡眠呼吸障害患者の 20% 程度が肺高血圧症を合併する。

✕ stage IV の患者では最大 90% の症例で平均肺動脈圧 > 20 mmHg であったと報告されている。

✕ 肺高血圧症の合併が多い。

✕ 2021 年に発表された間質性肺炎に対する吸入トレプロスチニルの有効性を示す報告を除き、一般的に肺疾患に伴う肺高血圧症に対する肺血管拡張薬の有用性は示されていない。

○ 肺疾患に伴う肺高血圧症の治療は、原疾患に対する治療と低酸素血症例に対する酸素療法が基本である。

○ 膠原病に伴う肺高血圧症に対しては免疫抑制剤の効果が期待できる。

✕ 膠原病の中でも、強皮症に伴う肺高血圧症は免疫抑制剤の有効性は期待できず、肺血管拡張薬による治療を行う。

○ 主な誘発因子として血流の停滞、血管内皮障害、血液凝固能亢進の Virchow の 3 徴が挙げられる。

✕ 概ね発症 2 週間以内のものが急性肺血栓塞栓症とされる。

○ 同様に発症確率の評価方法としてジュネーブ・スコア、改訂ジュネーブ・スコアが知られている。

✕ 臨床重症度分類は血行動態と心臓超音波検査での右心負荷所見を元に分類される。